طبع فى 19:50:45 11/10/2026

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سعاد على يوسف علي

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مصر القديمه **العنوان :** ش الزهراء

رقم البطاقة : 27311082800741 **رقم التليفون :** 01253614867 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 08-11-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ----------**قسم :** ----------

جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------

ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سعاد على يوسف على
National ID: 27311082800741

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



سعاد

علي يوسف علي

٢٥ ش خالدبن الوليدش الزهراء

مصر القديمة - القاهره

٢٧٣ ١١ ٠٨ ٢٨ ٠٠٧ ٤١

١٩٧٣/١١/٢٨

KS1953064



٢٧٣١١٠٨٢٨٠٠٧٤١

ربة منزل

٢٠٢٤/٠٨



أنثى مسلمة أرملة

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٨/٢٦



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient's Name:	**Soad Ali Youssef Ali**
Date:	**2026-06-27**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Left breast lesion measuring 59 x 48 mm with left axillary enlarged lymph node measuring 42 x 27 mm for sono-mammography.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. Multiple bilobar well defined hypodense focal lesions largest measuring 13 x 10 mm at segment IV. No dilated biliary radicles.
- Gall bladder calculus is seen.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- **Multiple bilobar hepatic focal lesions ? metastatic for dynamic MR study.**

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name : Soad Ali Youssef Ali	**Date : 02-07-2026 07:14**
Branch : Dokki	**Medical No. : 407510**
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt	

Whole-Body Bone Scintigraphy Report

Indication: Staging and evaluation of a primary left breast tumor. The 53-year-old female patient reports no active bony aches.

Technique: Following the intravenous administration of Tc-99m MDP, whole-body anterior and posterior planar imaging was performed.

Findings

- The study reveals a symmetric, physiologic distribution of the radiotracer throughout the axial and appendicular skeleton.
- There are no focal areas of abnormally increased or decreased radiotracer uptake to suggest osteoblastic metastatic disease or primary bone malignancy.
- The skull, vertebral column, sternum, ribs, pelvis, and long bones of the upper and lower limbs show normal osseous tracer localization.
- Non-specific mild, bilateral periarticular uptake is noted at the knees, consistent with mild degenerative change.
- The kidneys and urinary bladder are visualized normally, with symmetric renal parenchymal excretion and no evidence of urinary tract obstruction. Soft tissue background clearance is normal and appropriate for the patient's age.

Impression

- Normal whole-body bone scan. There is no scintigraphic evidence of osteoblastic metastatic skeletal disease.
- Follow up as per clinical pathway.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

الى من يهمه الامر / جوستاف روسى انترناشيونال-مصر

بالاشارة الي قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ، والذي يتضمن بوجوب خضوع المقيمين بمحافظات التطبيق اجباريا بالمنظومة وفقا لمحل الاقامة ببطاقة الرقم القومي داخل احدي محافظات التطبيق، وبالاشارة الي بدء التشغيل الفعلي بتاريخ 2025/7/1 لمنظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة اسوان

برجاء التفضل بالعلم بأنه قد تم الاستعلام على بيانات المواطن /سعاد على يوسف على تحمل بطاقة الرقم 27311082800741 المرفقه طيه والتي قد تم اصدارها في تاريخ بمحل الاقامة في محافظة القاهره

وبناء علي ما سبق في ان المستفيد المذكور من غير الخاضعين لمنظومة التامين الصحي الشامل .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

مدير الفرع

مدير الاداره
الفسترفديين

مدير اداره
التسجيل والاصدار

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :2026-4-21

جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) سعاد على يوسف على بطاقة رقم 27311082800741

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2026-4-21

الموظف المختص

محمود عبدالله

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1954391

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

٥٥ 8037

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

Patient ID: 94868	Patient Name English: Suad Ali Youssef Ali
٥٢ سنة, ٥ شهر :Age	2026/04/20 02:37:47 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 53-year-old lady with negative family history complaining of left breast lump of three months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- LOQ, middle third irregular speculated high density mass lesion with calcific foci within. Anterior linear density is seen inseparable from such lesion and reaching the nipple.
- Diffusely thickened skin and coarsened trabeculae.
- **Ultrasound** demonstrated LOQ, 7 o'clock, middle third, 2.5 cm from nipple, 8 mm deep to the skin, irregular anti-parallel heterogenous hypoechoic solid mass lesion with mild internal vascularity on color doppler study measuring 45 x 27 mm. anterior ductal extension through segmental dilated is noted through segmental dilated ducts reaching 6 mm in caliber with clear content, yet accompanied by recent nipple retraction.
- Diffusely thickened skin reaching 6 mm with coarsened trabeculae, minimal interstitial and mild subdermal edema.
- Multiple (more than three) enlarged axillary LNs (levels 1, ,2 & 3) are noted, largest measured 19 x 11 mm.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): LOQ locally advanced suspicious process with ipsilateral pathological axillary lymph nodes.

Recommendations:

For US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Much Obliged,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

USTAVE OUSSY
RNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سعاد على يوسف على	Request No.	: 13006057
Patient No.	: 27311082800741	Request Date	: 22/04/2026
Path No.	: 1135/26	Verification Date	: 12/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 52 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast LOQ mass, BIRADs 5.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 22/04/2026, at 12:50 pm, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.3 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
* Ductal carcinoma in situ: Intermediate grade DCIS (Cribriform pattern with comedo type necrosis).
* Perineural invasion: Absent.
* Angioinvasion: Absent.
* Necrosis: Focal.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.
- Intermediate grade ductal carcinoma insitu (Cribriform pattern with comedo type necrosis).
- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghonaim.

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

JSTAVE/
OUSSY
INATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سعاد على يوسف على	Request No.	: 13006057
Patient No.	: 27311082800741	Request Date	: 22/04/2026
Path No.	: 1135/26	Verification Date	: 12/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 52 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast LOQ mass, BIRADs 5 diagnosed "Invasive duct carcinoma grade 3 with intermediate grade DCIS (Cribriform pattern with comedo type necrosis).
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 22/04/2026, at 12:50 pm, Cold ischemia time: 20 seconds.

Technique:
Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
IPT (All controls showed appropriate reactivity):
ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
Ki67%: 70%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
IPT:
ER: Negative (score 0/8).
PR: Negative (score 0/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67%: 70%.

Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, 1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

ISTAVE/
OUSSY
NATIONAL

Patient Name	الأستاذه / سعاد على يوسف على	Request No.	13006057
Patient No.	27311082800741	Request Date	22/04/2026
ath No.	1135/26	Verification Date	12/05/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	52 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

nd 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, termediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
Scoring system: "Her2"
eference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining bserved. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely erceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane aining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
HC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and ithin >10% of
ie invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 0% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, tense > 10% of tumor cells.

ignature
r. Walaa Ibrahem Ghonaim.

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]